INFORME ANALÍTICO v0.6

No-show y costo de capacidad

CESFAM El Monte

Análisis reproducible enero–julio de 2026 | Versión 0.6

Equipo Magíster en Data Science · CESFAM El Monte

25 de agosto de 2026

Resumen ejecutivo

La línea base candidata de enero a julio de 2026 es 11,42%: 16.543 no-shows sobre 144.800 citas candidatas. El resultado utiliza una llave fina por paciente seudonimizado, fecha, profesional, instrumento y tipo de atención, excluyendo 629 contradicciones exactas. Todavía no constituye una tasa institucional validada.

La nueva dotación permite vincular 316 de 327 registros de la nómina: 96,6% de las personas y 98,6% de los haberes. Con equivalencias explícitas entre instrumentos Rayen y cargos, se valoriza 90,5% de los no-shows sin imputar un promedio institucional a las profesiones no mapeadas.

El escenario central supone 30 minutos por cupo. La capacidad asociada asciende a $90.518.324 usando sólo haberes; $112.304.893 con personal total; $124.883.990 con personal y bienes/servicios; y $137.029.373 con todos los gastos devengados de Salud. Son totales del período enero–julio, no montos mensuales.

> **Lectura recomendada:** comunicar un rango central de $112 a $137 millones para enero–julio de 2026, equivalente a $16,0–$19,6 millones mensuales en promedio. Es capacidad contable absorbida, no ahorro de caja ni costo marginal evitable.

1. Pregunta de decisión y alcance

El informe responde cuánto no-show puede identificarse con los extractos disponibles, dónde se concentra y qué orden de magnitud financiero representa la capacidad programada que no termina en una prestación efectiva.

Dimensión	Resultado	Estado de evidencia
Magnitud	11,42% (16.543/144.800)	Candidata; agenda no completa
Sensibilidad metodológica	10,42%–11,42%	Depende de la llave de contradicción
Cobertura dotación–nómina	96,6% personas; 98,6% haberes	Alta; julio versus agosto
Cobertura de costeo	90,5% de los no-shows	Sólo equivalencias profesionales explícitas
Costo absorbido central	$112–$137 millones	30 minutos; enero–julio
Modelo predictivo	No habilitado	Falta target e intervención validados

2. Fuentes y límites

Fuente	Cobertura	Uso y limitación
Actividades Rayen	323.466 filas	Construcción de atenciones; no es agenda completa
Inasistentes Rayen	17.173 filas	Numerador; sin id ni hora de cita

Fuente	Cobertura	Uso y limitación
Keirón	76.050 registros	Matching exploratorio, no causal
Balance Salud	$4.287.010.964 devengados a junio	Estructura agregada de gastos
Nómina julio	327 registros; $471.982.808	Haberes, jornada y categoría; sin aportes patronales
Dotación agosto	318 funcionarios; 38 cargos	Cargo, jornada y contrato; período distinto

La nómina y la dotación contienen información laboral confidencial. El análisis utiliza el identificador interno sólo para vincular en memoria, trabaja después con hashes y entrega exclusivamente resultados agregados.

3. Línea base y reconciliación metodológica

Versión	Atenciones	No-show	Denominador	Tasa
Anterior	125.420	14.596	140.016	10,42%
v0.4–v0.6	128.257	16.543	144.800	11,42%
Cambio	+2.837	+1.947	+4.784	+1,00 pp

La versión anterior excluía cualquier paciente que figurara atendido e inasistente el mismo día. La versión actual excluye sólo contradicciones exactas en la llave fina y conserva citas diferentes de una misma persona. El aumento es metodológico, no temporal.

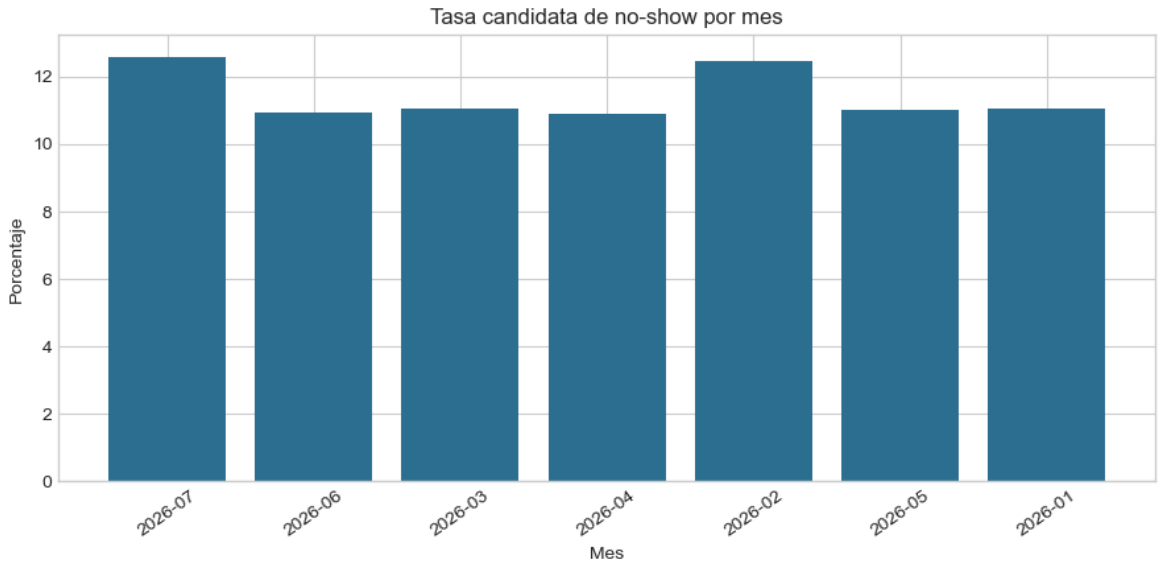


Figura 1. Tasa candidata mensual de no-show, enero–julio de 2026. Fuente: notebook v0.6 ejecutado.

4. Concentración operacional

Instrumento	No-shows	Tasa candidata	Lectura
Medicina	2.820	7,5%	Mayor volumen; tasa menor
Odontología	2.444	17,3%	Alto volumen y tasa
Enfermería	1.763	11,6%	Volumen relevante
Kinesiología	1.733	14,8%	Alta concentración
Nutrición	1.534	18,9%	Segmento prioritario
Psicología	1.398	16,5%	Alta tasa y volumen

La prioridad no debe definirse sólo por tasa. Medicina presenta el mayor número de ausencias pese a una tasa menor, mientras odontología, nutrición y psicología combinan tasa y volumen. La duración real y la demanda de reemplazo pueden cambiar el orden financiero.

5. Keirón: señal descriptiva, no efecto causal

Estado	Citas vinculadas	No-show	Tasa candidata
Confirmadas	23.905	2.128	8,9%
Sin responder	7.933	1.998	25,2%
Falla de envío	7.064	1.868	26,4%
Canceladas	1.175	882	75,1%

El cruce nominal unívoco por día vincula 41.335 citas candidatas (28,5%). La tasa elevada entre canceladas sugiere problemas de actualización o conciliación. No demuestra que confirmar cause asistencia ni que cancelar cause inasistencia.

6. Método de valorización financiera

El cálculo parte del haber por hora contratada de cada profesión y multiplica los no-shows mapeados por una duración supuesta. Luego aplica factores de absorción derivados del gasto devengado promedio mensual de enero–junio.

Nivel	Base mensual	Factor	Qué representa
Haberes directos	$471.982.808	1,00×	Capacidad salarial
Personal total	$585.582.858	1,24×	Proxy de personal completo
Personal + bienes/servicios	$651.173.086	1,38×	Operación y suministros absorbidos
Gasto total de Salud	$714.501.827	1,51×	Costo institucional absorbido

Advertencia: los factores distribuyen gastos generales proporcionalmente sobre horas contratadas. No prueban que todos los gastos sean causados por las citas ni que desaparezcan cuando se reduce el no-show.

7. Resultado enero–julio y equivalente mensual

Nivel de costeo	Enero–julio	Promedio mensual	Por no-show mapeado
Haberes	$90.518.324	$12.931.189	$6.043
Personal total	$112.304.893	$16.043.556	$7.497
Personal + bienes/servicios	$124.883.990	$17.840.570	$8.337
Gasto total absorbido	$137.029.373	$19.575.625	$9.148

Los montos corresponden al conjunto de no-shows entre enero y julio, usando el costo mensual de referencia para valorizar las horas asociadas. El promedio mensual divide el total del período por siete y facilita comparación presupuestaria; no debe confundirse con el gasto mensual total del Área.

8. Sensibilidad por duración

Duración	Haberes	Personal total	Personal + bienes	Gasto total
20 minutos	$60.345.549	$74.869.929	$83.255.994	$91.352.915
30 minutos	$90.518.324	$112.304.893	$124.883.990	$137.029.373
45 minutos	$135.777.486	$168.457.340	$187.325.986	$205.544.059
60 minutos	$181.036.648	$224.609.787	$249.767.981	$274.058.745

La duración explica gran parte de la incertidumbre. Hasta obtener tiempos reales por prestación, el informe recomienda mantener visible la matriz completa y usar 30 minutos únicamente como escenario central de trabajo.

9. Escenarios de capacidad aprovechada

Reasignación efectiva	Capacidad absorbida aprovechada	Interpretación
25%	$34.257.343	Cota inicial de utilización
50%	$68.514.686	Escenario intermedio
75%	$102.772.029	Escenario exigente

Estos montos no son ahorro ni ingreso adicional. Representan el valor contable de capacidad que podría terminar en atención efectiva si existe demanda compatible, contacto oportuno, aceptación y reasignación comprobada.

10. Recomendaciones y próximos pasos

Orden	Acción	Qué mejora
1	Obtener duración programada y realizada por prestación	Sustituye el supuesto de 30 minutos
2	Separar horas clínicas y administrativas	Evita valorizar toda la jornada como agenda
3	Obtener aportes patronales y diccionario de gastos	Refina factores de absorción
4	Identificar unidad y establecimiento clínico	Permite costos locales, no sólo Área de Salud
5	Instrumentar oferta y reasignación	Convierte capacidad teórica en valor observado
6	Validar proceso con Natalia Díaz y Daniela Gómez	Contrasta reglas SOME y Calidad

11. Conclusión

La evidencia disponible sostiene que el no-show representa un problema material. Bajo el escenario central, la capacidad asociada se ubica entre $112 y $137 millones durante enero–julio, equivalente a $16,0–$19,6 millones mensuales. Esta valorización mejora la lectura basada sólo en remuneraciones, pero debe presentarse como costo de capacidad absorbida y no como pérdida financiera realizada.

La decisión prioritaria sigue siendo operacional: validar agenda, duración, horas clínicas y reasignación. Sólo cuando esos componentes estén instrumentados podrá estimarse el beneficio financiero atribuible a una intervención y evaluar si corresponde desarrollar un modelo predictivo.

Fuentes y trazabilidad

Fuentes cuantitativas: Actividades e Inasistentes Rayen; Keirón; Balance Salud detallado 2026; Libro de Remuneraciones julio 2026; Planilla de Dotación agosto 2026. Cálculos reproducidos en analisis_no_show_cesfam_el_monte.ipynb, versión analítica 0.6.